

• VERSION LIGHT · GRATUIT

SANTÉ DIGESTIVE & HORMONALE FÉMININE

SIBO : *comprendre* les bases.

Les signes qui ne trompent pas, les 5 erreurs qui retardent la guérison, et un quiz pour savoir si votre profil correspond — avant de passer à l'action.

Par **Sabrina Castelli** — Naturopathe, ancienne patiente SIBO
Extrait du guide complet "SIBO : comprendre, tester, agir."

PREMIÈRE PARTIE

Ce qui se passe vraiment.

*Comprendre le SIBO en 10 minutes – sans
formation médicale, sans jargon inutile.*

CHAPITRE 01

Ce qu'est vraiment le SIBO.

Ce n'est pas "le stress", ni une sensibilité alimentaire, ni une colopathie fonctionnelle. C'est une prolifération bactérienne dans un endroit précis – identifiable, testable, traitable.

SIBO signifie *Small Intestinal Bacterial Overgrowth*. Votre intestin grêle, long de 6 mètres, est normalement très peu peuplé en bactéries. Dans le SIBO, des bactéries du côlon remontent et colonisent cet espace. Elles fermentent les glucides que vous mangez *avant* que votre intestin ait eu le temps de les absorber – produisant des gaz (hydrogène H₂, méthane CH₄, ou sulfure d'hydrogène H₂S) responsables de vos symptômes.

Ce n'est pas qu'un problème de confort. Non traité, le SIBO provoque une **malabsorption réelle** des vitamines B12, D, du fer et du magnésium – d'où la fatigue chronique et les carences récurrentes malgré une alimentation soignée.

LES 7 SIGNES QUI NE TROMPENT PAS

- Ballonnements marqués après les repas, surtout riches en glucides – empirent en fin de journée
- Transit perturbé : diarrhée chronique, constipation sévère, ou alternance imprévisible
- Fatigue profonde, non proportionnelle à vos nuits
- Carences répétées (B12, fer, vitamine D) malgré une alimentation équilibrée
- Reflux gastro-œsophagien associé à des troubles digestifs bas
- Brouillard mental – concentration difficile, mémoire floue après les repas
- **Les probiotiques aggravent vos symptômes** – c'est le signe le plus caractéristique du SIBO actif

LE SIGNAL QUE TOUT LE MONDE RATE

Si vous prenez des probiotiques et que vos ballonnements, votre fatigue ou vos réactions histaminiques s'aggravent – c'est probablement du SIBO. Les bactéries lactiques des probiotiques nourrissent directement la pullulation. Cessez-les avant tout autre chose.

SIBO VS INTESTIN IRRITABLE

Les études récentes montrent que **38 à 78% des personnes diagnostiquées "intestin irritable"** ont en réalité un SIBO — dont la plupart n'ont jamais été testées. L'intestin irritable est un diagnostic d'exclusion. Le SIBO est une cause identifiable.

Source : Pimentel M. et al. (2020) — ACG Clinical Guideline: SIBO. Am J Gastroenterol. / Ford AC et al. (2020) — Functional Bowel Disorders. Gastroenterology.

DEUXIÈME PARTIE

Les 5 erreurs qui retardent tout.

*Ce que la plupart des femmes font – souvent
sur conseil médical – et qui empire la
situation.*

CHAPITRE 02

Les 5 erreurs *qui retardent tout.*

Ces erreurs ne sont pas des fautes de votre part. Elles sont souvent conseillées par des professionnels qui ne connaissent pas le SIBO. Les identifier peut vous faire gagner des mois.

ERREUR 01

Commencer par les probiotiques

C'est la première chose que prescrivent la plupart des médecins et naturopathes face à des troubles digestifs. En cas de SIBO actif, c'est souvent la pire chose à faire. Les bactéries lactiques (*Lactobacillus*, *Bifidobacterium*) nourrissent directement la pullulation et aggravent les symptômes.

→ Les probiotiques viennent après l'éradication, jamais avant. Et pas n'importe lesquels : *Saccharomyces boulardii* est le seul indiqué en phase active.

ERREUR 02

Suivre un régime Low-FODMAPs à vie

Le régime Low-FODMAPs soulage les symptômes en réduisant la fermentation — mais il ne traite pas la cause. Certaines femmes le suivent pendant des années, voient leurs symptômes revenir dès qu'elles écartent des aliments, et pensent que c'est "leur sensibilité personnelle". C'est en réalité le signe que la pullulation est toujours là.

→ Low-FODMAPs = outil temporaire pendant le traitement, pas solution permanente.

ERREUR 03

Grignoter toute la journée

Entre les repas, votre intestin grêle se nettoie grâce à des contractions péristaltiques puissantes (le Complexe Moteur Migrant). Ce mécanisme ne fonctionne qu'à jeun. Chaque grignotage l'interrompt. Les femmes qui mangent en continu — même sainement — entretiennent la pullulation sans le savoir.

→ Laisser 4 à 5 heures entre les repas sans rien ingérer (sauf eau). C'est souvent plus efficace que n'importe quelle restriction alimentaire.

ERREUR 04

Traiter sans typer le SIBO

Il existe 3 types de SIBO (hydrogène, méthane, sulfure d'hydrogène) avec des protocoles différents. Prendre de la rifaximine seule pour un SIBO-méthane, c'est inefficace. Utiliser certaines plantes antimicrobiennes sur un SIBO-H₂S peut aggraver l'inflammation. Sans test, on traite à l'aveugle.

→ Un test respiratoire lactulose ou glucose est indispensable avant tout protocole.

ERREUR 05

Traiter le SIBO sans chercher la cause racine

40% des personnes rechutent dans les 9 mois après traitement. Pourquoi ? Parce qu'elles ont traité la pullulation sans identifier ce qui l'a déclenchée : hypothyroïdie non traitée, IPP au long cours, stress chronique qui paralyse la motilité, séquelle d'une gastro-entérite ancienne... Sans identifier le "premier domino", la récurrence est presque certaine.

→ Remonter la cascade causale est aussi important que le traitement lui-même.

TROISIÈME PARTIE

Est-ce que c'est mon profil ?

*Un quiz clinique pour identifier si vos
symptômes correspondent à un profil SIBO –
et lequel.*

CHAPITRE 03

Quiz — Est-ce *mon profil SIBO ?*

MODE D'EMPLOI

Cochez OUI ou NON pour chaque affirmation. Comptez vos OUI à la fin. Ce quiz n'est pas un diagnostic — c'est un outil d'orientation clinique basé sur les critères de Rome IV et les guidelines ACG 2020.

SECTION A — SYMPTÔMES DIGESTIFS

Je me bats avec des **ballonnements presque quotidiens**, surtout après les repas — et ils empirent en fin de journée.

☐ OUI☐ NON

Mon transit est **imprévisible** : constipation sévère, diarrhée, ou les deux en alternance — sans raison évidente.

☐ OUI☐ NON

J'ai des **douleurs ou crampes abdominales** basses qui ne disparaissent pas malgré les antispasmodiques.

☐ OUI☐ NON

J'ai des **reflux gastro-œsophagiens** en plus de mes troubles digestifs bas.

☐ OUI☐ NON

Quand je prends des probiotiques, mes symptômes **s'aggravent** plutôt qu'ils ne s'améliorent.

☐ OUI☐ NON**SECTION B — SIGNES SYSTÉMIQUES**

J'ai une **fatigue chronique** difficile à expliquer — pas proportionnelle à mes nuits ni à mon activité.

☐ OUI☐ NON

J'ai des **carences répétées** (B12, fer, vitamine D) malgré une alimentation que je considère équilibrée.

☐ OUI☐ NON☐ OUI☐ NON

g
mémoire qui flanche.

Je réagis à de nombreux aliments — intolérance au lactose, au fructose, aux FODMAPs, à l'histamine.

OUI

NON

SECTION C — CONTEXTE ET DÉCLENCHEURS

Mes symptômes ont commencé ou se sont aggravés **après une gastro-entérite sévère**, une prise d'antibiotiques, ou une chirurgie abdominale.

OUI

NON

Je prends ou j'ai pris des **IPP** (oméprazole, pantoprazole, esoméprazole) pendant plus de 3 mois.

OUI

NON

J'ai une **hypothyroïdie**, un SOPK, de l'endométriose, ou un déséquilibre hormonal diagnostiqué ou suspecté.

OUI

NON

On m'a diagnostiqué un **syndrome de l'intestin irritable** sans jamais me proposer de test respiratoire.

OUI

NON

CALCULEZ VOTRE SCORE — COMPTEZ VOS OUI

SCORE	ORIENTATION	PROCHAINE ÉTAPE
1–3	PROFIL PEU PROBABLE Quelques symptômes isolés, peu caractéristiques.	Explorer d'autres pistes (dysbiose colique, intolérances alimentaires simples).
4–6	PROFIL À INVESTIGUER Plusieurs signes concordants — un test est justifié.	Demander un test respiratoire lactulose à votre médecin ou via un laboratoire en ligne.
7–13	PROFIL TRÈS CONCORDANT Tableau clinique fortement évocateur — ne pas rester sans réponse.	Test respiratoire en priorité + bilan complet (thyroïde, fer, B12, hormones).

CE QUE CE QUIZ NE FAIT PAS

Ce quiz oriente — il ne diagnostique pas. Seul un test respiratoire peut confirmer un SIBO et en identifier le type. Le guide complet vous explique comment l'obtenir, comment vous y préparer, et surtout : comment lire vos résultats vous-même.

LA SUITE, DANS LE GUIDE COMPLET

Maintenant, comprendre pour agir.

Vous avez le tableau clinique. La prochaine étape : comprendre votre type de SIBO, obtenir le bon test, et suivre le protocole dans le bon ordre.

- ✓ Physiologie détaillée avec 5 schémas sur mesure
- ✓ Les 3 types de SIBO — H₂, CH₄, H₂S — et leurs protocoles
- ✓ Test respiratoire : comment le demander, le préparer, lire vos résultats
- ✓ Le protocole en 4 phases dans le bon ordre
- ✓ Alimentation stratégique — listes pratiques semaine 1-2
- ✓ Plantes antimicrobiennes avec dosages sourcés
- ✓ SIBO & hormones : l'estrobolome, SOPK, endométriose, ménopause
- ✓ Fiche imprimable : ma timeline SIBO
- ✓ Glossaire 16 termes + 13 sources scientifiques

22€

PDF · téléchargement immédiat

avitaserena.com/ebook-sibo